

CAPÍTULO 14.29

Pelvispondiloartropatías - Generalidades

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a las Espondiloartropatías (PEA)

Las **espondiloartropatías seronegativas** (o pelvispondilopatías) constituyen un grupo de enfermedades inflamatorias crónicas que comparten características clínicas, radiológicas y genéticas comunes. Su nombre "seronegativas" deriva de la ausencia de autoanticuerpos clásicos en el suero.

- El grupo principal está compuesto por:
- **Espondilitis Anquilosante (EA):** La patología prototípica y más importante del grupo.
- **Espondiloartritis Axial No Radiográfica:** Similar a la EA, pero sin cambios visibles en la radiografía convencional (se detecta por resonancia).
- **Artritis Psoriática:** Asociada a la presencia de psoriasis cutánea o ungueal.
- **Artritis asociada a Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII):** Relacionada con la **Enfermedad de Crohn** o la **Colitis Ulcerosa**.
- **Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter):** Ocurre tras una infección (post-infecciosa), frecuentemente digestiva o urogenital. El Síndrome de Reiter es una variante con compromiso sistémico mayor.
- **Espondilitis Indiferenciada:** Cuadros que sugieren una PEA pero no cumplen criterios específicos para ninguna de las anteriores.

NOTA CLÍNICA

A diferencia de la **Artritis Reumatoide**, donde el tejido diana es la sinovial, en las espondiloartropatías el sitio primario de inflamación es la **entesis** (lugar donde tendones, ligamentos y cápsulas se insertan en el hueso).

Laboratorio y Genética

La característica definitoria de estas patologías es la **ausencia de marcadores serológicos** típicos de otras enfermedades del tejido conectivo.

- **Seronegatividad:** Factor Reumatoide (FR), ANA (Anticuerpos Antinucleares) y ANCA son **negativos**.
- **HLA-B27:** Es un gen del complejo mayor de histocompatibilidad (no es un anticuerpo). Su positividad se asocia fuertemente a la Espondilitis Anquilosante y, en menor medida, al resto de las PEA. No es diagnóstico por sí solo, pero aumenta la sospecha clínica.

Diagnóstico por Imágenes

El estudio de imagen es fundamental para evaluar el compromiso axial, especialmente en las articulaciones sacroilíacas.

- **Radiografía de Sacroilíacas:** Es el examen inicial. Si muestra signos de **sacroileítis** (erosiones, esclerosis o anquilosis), confirma el compromiso axial.
- **Resonancia Magnética (RM) de Sacroilíacas y Columna:** Es el mejor examen y el más sensible. Permite detectar cambios precoces (edema óseo) cuando la radiografía aún es normal (fase no radiográfica).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, ante un cuadro de lumbago inflamatorio, la **radiografía** es el primer paso, pero si es negativa y la sospecha es alta, el siguiente paso es la **RM**.

Manifestaciones Clínicas Articulares

Las manifestaciones se dividen según el territorio afectado, aunque un mismo paciente puede presentar ambas:

1. Compromiso Axial

Es el sello de la **Espondilitis Anquilosante**. Se manifiesta principalmente como: - **Sacroileítis:** Inflamación de las articulaciones sacroilíacas. - **Lumbago Inflamatorio:** Dolor lumbar de inicio insidioso, que empeora con el reposo y **mejora significativamente con la actividad física**. Suele presentarse en pacientes jóvenes. - Compromiso de toda la columna y articulaciones costovertebrales/costocondrales.

2. Compromiso Periférico

Más frecuente en la Artritis Psoriática y la Artritis Reactiva. Se caracteriza por: - **Oligoartritis Asimétrica:** Afecta de 2 a 4 articulaciones de forma no simétrica. - Involucra tanto grandes articulaciones (rodilla, cadera, tobillo) como pequeñas (interfalángicas de manos y pies).

TABLA 14.29.1: TIPO DE ARTRITIS VS DISTRIBUCIÓN

TIPO DE ARTRITIS	DISTRIBUCIÓN	CARACTERÍSTICAS CLAVE
Axial	Esqueleto central	Lumbago inflamatorio, sacroileítis, rigidez matinal.
Periférica	Extremidades	Oligoartritis asimétrica, afectación de grandes y pequeñas articulaciones.

Manifestaciones Extraarticulares

Estas enfermedades son sistémicas y frecuentemente afectan otros órganos:

- **Uveítis Anterior (Iridociclitis):** Es la manifestación extraarticular más frecuente (20-30% en EA). Se presenta como ojo rojo doloroso con fotofobia.
- **Manifestaciones Cutáneas:**
 - - **Eritema Nodoso:** Nódulos subcutáneos dolorosos (frecuente en EII y Artritis Reactiva).
 - - **Pioderma Gangrenoso:** Úlceras cutáneas necróticas (asociado a EII).
 - - **Psoriasis:** Placas eritemato-escamosas.
- **Entesitis y Dactilitis:**
 - - **Entesitis:** Inflamación del tendón de Aquiles o fascia plantar.
 - - **Dactilitis:** Inflamación difusa de un dedo ("dedo en salchicha"), muy característica de la **Artritis Psoriática**.
- **Compromiso Genital:** Uretritis o úlceras genitales (típico de la Artritis Reactiva).
- **Compromiso Intestinal:** Inflamación de la mucosa intestinal, evidente en las asociadas a EII.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La presencia de un **ojo rojo doloroso** en un paciente con lumbago crónico debe hacer sospechar inmediatamente una **Uveítis Anterior**, una urgencia oftalmológica que requiere derivación.

Resumen de Variantes Clínicas

- **Artritis Reactiva:** Clásicamente sigue a una infección entérica (Salmonella, Shigella) o genital (Chlamydia). El cuadro completo incluye artritis, uretritis y conjuntivitis.
- **Artritis Psoriática:** Puede preceder a las lesiones cutáneas. Es muy característica la afectación de las interfalángicas distales y la presencia de dactilitis.
- **Artritis asociada a EII:** El compromiso periférico suele correlacionar con la actividad de la enfermedad intestinal, mientras que el compromiso axial suele ser independiente de los brotes digestivos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para diferenciar el lumbago: - **Mecánico:** Empeora con el ejercicio, mejora con el reposo. - **Inflamatorio:** Mejora con el ejercicio, empeora con el reposo. ¡Pregunta clásica de examen!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"¿Qué característica de laboratorio define a las pelvispondiloartropatías como 'seronegativas'?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Pelvispondiloartropatías - Generalidades. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Pelvispondiloartropatías: espondilitis anquilosante, no radiográfica, psoriásica, asociada a EII, reactiva e indiferenciada
- Seronegativas (sin FR, ANA ni ANCA), pero pueden tener HLA-B27 positivo (gen, no anticuerpo)
- Artritis periférica: oligoartritis asimétrica de grandes y pequeñas articulaciones
- Artritis axial: sacroileítis + lumbago inflamatorio (aumenta con reposo, disminuye con actividad)
- Primer examen: radiografía de sacroilíacas; mejor examen: resonancia magnética
- Manifestaciones extraarticulares: uveítis (20-30%), entesitis, dactilitis (dedos en salchicha), eritema nodoso
- Dactilitis especialmente frecuente en artritis psoriásica; síntomas genitales en artritis reactiva

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PELVISPONDILOARTROPATÍAS - GENERALIDADES)**PREGUNTA 1**

¿Qué característica de laboratorio define a las pelvispondiloartropatías como 'seronegativas'?

- A)** ANA positivo con factor reumatoide negativo
- B)** ANCA positivo con ANA negativo
- C)** Ningún anticuerpo positivo (ni FR, ni ANA, ni ANCA)
- D)** Anti-CCP positivo
- E)** Complemento bajo

PREGUNTA 2

Paciente con lumbago que aumenta con el reposo y mejora con la actividad física. ¿Qué tipo de lumbago presenta?

- A)** Lumbago mecánico
- B)** Lumbago inflamatorio
- C)** Lumbago por fractura vertebral
- D)** Lumbago por hernia discal
- E)** Lumbago por estenosis raquídea

PREGUNTA 3

¿Cuál es el primer examen de imagen a solicitar ante sospecha de pelvispondiloartropatía con afectación axial?

- A)** Resonancia magnética de columna
- B)** TAC de columna
- C)** Radiografía de sacroilíacas
- D)** Gammagrafía ósea
- E)** Ecografía articular

RESUMEN: PELVISPONDILOARTROPATÍAS - GENERALIDADES

Las pelvispondiloartropatías (espondilopatías seronegativas) incluyen: espondilitis anquilosante, espondilitis no radiográfica, artritis psoriásica, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reactiva (síndrome de Reiter) y espondilitis indiferenciada. Son seronegativas (sin anticuerpos positivos: ni FR, ni ANA, ni ANCA), pero pueden tener HLA-B27 positivo (un gen, no un anticuerpo). Las manifestaciones articulares pueden ser periféricas (oligoartritis asimétrica de grandes y pequeñas articulaciones, lo más frecuente excepto en espondilitis anquilosante) o axiales (sacroileítis y afectación de columna, lo más frecuente en espondilitis anquilosante). La primera imagen es la radiografía de sacroilíacas; si es normal, se pide resonancia magnética. Las manifestaciones extraarticulares incluyen uveítis (20-30%), eritema nodoso, pioderma gangrenoso, entesitis (fascitis plantar, entesitis aquiliana), dactilitis (dedos en salchicha) y afectación genital/intestinal. Todas comparten un cuadro clínico similar con lumbago inflamatorio (aumenta con reposo, disminuye con actividad).